

ITU — Infecção do Trato Urinário

Pielonefrite aguda · ITU complicada em internação

CID N10 · N390

CRITÉRIOS POSITIVOS — SOMAM PONTOS

Critério	Parâmetro	Pts	Base clínica
Afebril $\geq$ 48h	Temperatura $< 37,8^{\circ}\text{C}$ por $\geq$ 48h consecutivas	+25	Protocolo MS — febre resolvida é o principal marco de estabilização na ITU
Hemodinâmica estável	PA $\geq$ 90/60 mmHg sem vasopressor ativo	+20	Critérios SIRS — ausência de instabilidade sistêmica
Tolerância oral $\geq$ 24h	Aceita VO sem náusea/vômito; apto para transição ATB oral	+20	IDSA Guidelines 2011 — pré-requisito obrigatório para transição para antimicrobiano oral
ATB parenteral $\geq$ 72h	Completo fase EV mínima com resposta clínica documentada	+15	MS/ANVISA — mínimo 72h IV para pielonefrite aguda grave
Leucocitose em resolução	Leucócitos $< 12.000/\text{mm}^3$ ou redução $\geq 30\%$ em relação ao pico	+10	Marcador laboratorial de resposta terapêutica ao ATB
Função renal preservada	Creatinina sérica estável ou em queda nas últimas 24h	+10	Ausência de lesão renal aguda — segurança para transição oral e transferência
Ausência de dispositivo vesical de demora	Sonda vesical de demora (SVD) removida ou não utilizada	+15	IDSA/CDC — remoção precoce da SVD reduz risco de ITU associada a cateter e favorece resolução clínica

CRITÉRIOS NEGATIVOS — SUBTRAEM PONTOS

Critério	Parâmetro	Pts	Base clínica
Febre persistente	T $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$ nas últimas 24h	-30	Falha terapêutica ou foco não controlado — contraindicação à transferência
Germe resistente em tratamento IV	Cultura com ESBL, KPC ou MDR aguardando ajuste de ATB parenteral	-25	Necessidade de antimicrobiano IV para germe resistente não disponível ambulatorialmente
Lesão renal aguda ativa	Creatinina $> 2\times$ basal ou oligúria ($< 0,5 \text{ mL/kg/h}$ por $> 6\text{h}$)	-20	Complicação que exige monitorização laboratorial e manejo hospitalar
Sinais de sepse urinária	FC $> 100 \text{ bpm}$ + FR $> 20 \text{ irpm}$ + T $> 38^{\circ}\text{C}$ (critérios SIRS ≥ 2)	-20	Instabilidade sistêmica — risco de progressão para choque séptico
Sonda vesical de demora (SVD) mantida	Dispositivo vesical de demora em uso sem indicação imperiosa documentada	-20	Presença de SVD é fator de risco independente para ITU-AC (CAUTI) e perpetuação do foco infeccioso
Procedimento urológico recente	Cateter duplo J, litotripsia ou cistoscopia nas últimas 48h	-10	Risco de reativação infecciosa e instabilidade pós-procedimento

AVALIAÇÃO DE DISPOSITIVO VESICAL — OBRIGATÓRIA ANTES DA TRANSFERÊNCIA

Situação do dispositivo	Conduta recomendada	Impacto no score
Sem cateter vesical	Situação ideal — sem restrição relacionada ao dispositivo	+15 (já incluído nos critérios positivos)
Cateter de alívio (intermitente)	Aceitável para transferência se micção espontânea não estabelecida; reavaliar no destino	0 (neutro)
Sonda vesical de demora (SVD) em uso	Avaliar indicação: remover se possível antes da transferência; documentar justificativa se mantida	-20 (já incluído nos critérios negativos)

Situação do dispositivo	Conduta recomendada	Impacto no score
SVD com indicação imperiosa mantida	Obstrução, bexiga neurogênica ou retenção urinária documentada — transferência possível com registro formal	−10 (penalização reduzida se indicação justificada)
≥ 70	40–69	< 40
Apto para transferência / alta / habilitação	Reavaliar em 24h	Permanece internado

Critérios de bloqueio absoluto — score ignorado, não transferir

- Choque séptico (PAM < 65 mmHg com vasopressor ativo)
- Abscesso renal ou perirrenal confirmado em tratamento
- Obstrução urinária não resolvida (hidronefrose obstrutiva ativa)
- Germe MDR com ATB IV sem equivalente oral eficaz disponível no destino
- SVD de demora mantida por obstrução aguda não resolvida

Fontes: IDSA/ESCMID Guidelines ITU 2011 · MS — Protocolo Clínico para ITU Complicada · ANVISA — Prevenção de CAUTI 2022 · CDC — Guideline for Prevention of Catheter-Associated UTI 2009 · ANVISA — Uso Racional de Antimicrobianos 2022

Pneumonia bacteriana

PAC — Pneumonia adquirida na comunidade · em fase de resolução

CID J18 · J159 · J181

CRITÉRIOS POSITIVOS — SOMAM PONTOS

Critério	Parâmetro	Pts	Base clínica
Afebril ≥ 48 h	T < 37,8°C por 48h consecutivas	+25	ATS/IDSA 2019 — critério principal de estabilização PAC
SpO2 estável em ar ambiente	SpO2 $\geq 92\%$ sem suporte de O2 suplementar	+25	BTS Guidelines — independência de oxigênio é pré-requisito para transferência segura
FR normalizada	FR ≤ 24 irpm em repouso	+15	PORT Score — parâmetro de estabilidade do padrão respiratório
PA estável	PAS ≥ 90 mmHg sem vasopressor ativo	+15	CURB-65 — ausência de hipotensão como critério de gravidade
Tolerância oral ≥ 24 h	Accita VO e medicação oral sem intercorrências	+10	ATS — pré-requisito para alta ou transição para ATB oral ambulatorial
ATB parenteral ≥ 5 dias	Fase EV mínima cumprida com resposta clínica documentada	+10	MS/SBPT — mínimo 5 dias IV para PAC grave hospitalizada
Imagem torácica com resolução	RX de tórax ou TC de tórax sem progressão de consolidações; ausência de novo derrame ou cavitação	+15	ATS/IDSA 2019 — resolução radiológica confirma resposta terapêutica; piora ou estabilidade sem melhora clínica exige reavaliação

CRITÉRIOS NEGATIVOS — SUBTRAEM PONTOS

Critério	Parâmetro	Pts	Base clínica
Dependência de O2 suplementar	Necessidade de cateter nasal, máscara de Venturi ou máscara com reservatório para manter SpO2 $\geq 92\%$	−30	Insuficiência respiratória em resolução — paciente não apto para transferência sem suporte O2 garantido no destino
SpO2 em queda	SpO2 < 92% em ar ambiente ou em uso de O2 suplementar	−35	Falha respiratória ativa — necessidade de escalonamento de suporte ventilatório

Critério	Parâmetro	Pts	Base clínica
Febre persistente	T ≥ 38°C nas últimas 24h	-25	Evolução desfavorável — reavaliar agente etiológico, resistência ou foco secundário
Derrame pleural significativo ou progressivo	Novo derrame ou ausência de resolução do derrame prévio na imagem	-20	Risco de empiema pleural — monitorização por imagem obrigatória antes da transferência
FR elevada	FR > 28 irpm em repouso	-15	Aumento do trabalho respiratório — sinal de instabilidade ventilatória
Confusão mental nova ou persistente	Alteração cognitiva aguda não prévia — critério C do CURB-65	-15	Sinal de gravidade sistêmica — associado a pior prognóstico no CURB-65
Imagem torácica com piora ou sem resolução	Progressão de consolidações, nova cavitação ou derrame em RX ou TC de tórax	-20	Falha terapêutica ou pneumonia necrotizante — contraindicação relativa à transferência; exige reavaliação do esquema ATB

AValiação do suporte ventilatório — obrigatória antes da transferência

Situação ventilatória	Conduta recomendada	Impacto no score
Em ar ambiente com SpO2 ≥ 92%	Situação ideal — sem restrição ventilatória para transferência	+25 (incluído nos critérios positivos)
Cateter nasal O2 ≤ 2 L/min com SpO2 estável	Transferência possível se destino dispõe de O2 e evolução é de desmame progressivo; documentar no sumário	-15 (penalização parcial)
Máscara com reservatório ou Venturi > 35%	Alto fluxo de O2 — não transferir; reavaliar em 24–48h para desmame	-30 (incluído nos critérios negativos)
VNI (BiPAP/CPAP) intermitente	Avaliar tendência de desmame; transferência somente se VNI for apenas noturna e destino tiver suporte adequado	-35
IOT / Ventilação mecânica invasiva	Bloqueio absoluto — não transferir enquanto em VM invasiva	Bloqueio absoluto

ESCALA CURB-65 — pontuação de gravidade (usada como fator de peso)

Letra	Critério	Peso no score DataCross
C	Confusão mental (novo episódio)	-15 se presente
U	Ureia > 43 mg/dL	-10 se presente
R	FR ≥ 30 irpm	-15 se presente
B	PAS < 90 mmHg ou PAD < 60 mmHg	-20 se presente
65	Idade ≥ 65 anos	-5 se presente

≥ 70

Apto para transferência / alta / habilitação

40–69

Reavaliar em 24h

< 40

Permanece internado

- Critérios de bloqueio absoluto — score ignorado, não transferir
- IOT / Ventilação mecânica invasiva em curso
 - VNI contínua (BiPAP/CPAP) sem perspectiva de desmame em 48h
 - SpO2 < 88% com O2 > 4 L/min ou FiO2 > 40%
 - Pneumonia necrotizante ou abscesso pulmonar em tratamento ativo

- Empiema pleural em drenagem ativa (dreno torácico)
- Progressão radiológica confirmada em RX ou TC de tórax nas últimas 24h (consolidação irreversível ou cavitação nova)

Fontes: ATS/IDSA PAC Guidelines 2019 · SBPT — Diretrizes Pneumonia 2018 · BTS Guidelines PAC 2009 · CURB-65 (Lim et al., Thorax 2003) · MS — Protocolo PAC SUS 2021 · PORT/PSI Score (Fine et al., NEJM 1997)

AVC — Acidente Vascular Cerebral

Isquêmico · hemorrágico · fase pós-aguda estável

CID I63 · I64 · I61

CRITÉRIOS POSITIVOS — SOMAM PONTOS

Critério	Parâmetro	Pts	Base clínica
Estabilidade neurológica	NIHSS sem piora nas últimas 48h	+30	ASA/AHA 2019 — ausência de progressão é marco para reabilitação
Via aérea protegida	Sem risco de aspiração · Glasgow ≥ 13	+20	MS — segurança para transferência a CER
PA controlada	PAS 130–180 mmHg estável	+15	AHA — alvo pressórico pós-AVC isquêmico
≥ 72h pós-evento	Fase hiperaguda encerrada	+15	MS — janela mínima antes de transferência para reabilitação
Deglutição avaliada	Avaliação fonoaudiológica realizada	+10	SBDCV — rastreio de disfagia obrigatório pré-alta
Anticoagulação iniciada	Se FA — anticoagulante iniciado	+10	AHA 2019 — início precoce se sem contraindicação

CRITÉRIOS NEGATIVOS — SUBTRAEM PONTOS

Critério	Parâmetro	Pts	Base clínica
Piora neurológica	Queda ≥ 2 pts no NIHSS em 24h	−40	Progressão do AVC — necessidade de monitorização intensiva
Transformação hemorrágica	Nova hemorragia no controle de imagem	−40	Contraindicação absoluta à transferência
Glasgow < 13	Rebaixamento de consciência	−30	Risco de aspiração e necessidade de monitorização
Hipertensão refratária	PAS > 220 mmHg sem controle	−20	Risco de expansão hemorrágica ou edema
Disfagia grave	Sem via oral segura — SNE ou GTT	−15	Necessidade de acompanhamento nutricional especializado

ESCALA NIHSS — USADA COMO MODIFICADOR DO SCORE DATACROSS

NIHSS	Gravidade	Modificador DataCross
0–4	AVC leve	+10 (favorece transferência precoce)
5–15	AVC moderado	0 (neutro — depende dos outros critérios)
16–20	AVC moderado-grave	−10 (atenção extra)
≥ 21	AVC grave	−25 (bloqueio quase certo)

ESCALA MRS — DESTINO PÓS-TRANSFERÊNCIA

mRS	Funcionalidade	Destino sugerido pelo DataCross
0–1	Sem ou mínima incapacidade	Alta domiciliar + ambulatório neurologia

mRS	Funcionalidade	Destino sugerido pelo DataCross
2–3	Incapacidade leve-moderada	CER — Centro Especializado de Reabilitação
4–5	Incapacidade grave	Atenção domiciliar AD3 ou ILPI
≥ 70	40–69	< 40
Apto para reabilitação	Reavaliar em 24h	Permanece na unidade

Critérios de bloqueio absoluto

- Menos de 24h do evento (fase hiperaguda)
- Hemicraniectomia recente (< 72h)
- Vasoespasma ativo (AVC hemorrágico)
- Trombólise IV nas últimas 24h — monitorização obrigatória
- Trombectomia mecânica — 24h de observação pós-procedimento

Fontes: AHA/ASA Stroke Guidelines 2019 · MS — Linha de Cuidado AVC 2013 · SBDCV — Protocolo AVC Isquêmico 2022 · NIHSS (NIH Stroke Scale) · mRS (Modified Rankin Scale) · Escala de Barthel